

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5007701-61.2024.4.02.5118/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MIDIA BRAGA DOS SANTOS DA SILVA DE ANDRADE (AUTOR)

RECORRENTE: DIEGO BRANDAO DE ANDRADE (AUTOR)

RECORRENTE: CALEB BRAGA DE ANDRADE (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA O TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUTOR MENOR IMPÚBERE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM CUSTO DO MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE EFICÁCIA CIENTÍFICA. PARECER DO NAT-JUS QUE APONTA DESCONHECIMENTO DOS EFEITOS DO CANNABIDIOL A LONGO PRAZO. ESGOTAMENTO DAS OPÇÕES TERAPÊUTICAS DO SUS NÃO DEMONSTRADA PELO AUTOR. SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e na forma da fundamentação supra. Condene a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em 10% do valor atualizado da causa, observados os parágrafos 2º e 3º do art. 98 do CPC. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5007701-61.2024.4.02.5118

510015741910 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5007701-61.2024.4.02.5118/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MIDIA BRAGA DOS SANTOS DA SILVA DE ANDRADE (AUTOR)

RECORRENTE: CALEB BRAGA DE ANDRADE (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus 200mg/ml para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A lide foi julgada nos seguintes termos:

*"Trata-se de ação ajuizada por **CALEB BRAGA DE ANDRADE** em face da **UNIÃO e do ESTADO DO RIO DE JANEIRO** objetivando "ao final seja confirmada a tutela de urgência para julgar procedente o pedido de fornecimento de 48 frascos de 30 mL do Canabidiol Golden CDB Plus 200 mg/ml". Pleiteia a concessão de tutela de urgência para imediato fornecimento do fármaco Canabidiol, conforme prescrição médica.*

Inicial e documentos anexados ao Evento 1.

Deferida a gratuidade de justiça no Evento 3.

Documentos elencados pela parte autora no Evento 12 e 23.

Parecer do NATJus, Evento 34.

Indeferida a tutela de urgência, bem como determinada a citação da parte ré no Evento 36.

Manifestação da parte autora no Evento 49. Elencou laudo médico no Evento 49, LAUDO2/3.

Contestação da União Federal no Evento 51.

Parecer Técnico do NATJUS-FEDERAL Nº 1638/2024 no Evento 54.

Réplica no Evento 55.

Conforme certificado no Evento 57, o Estado do Rio de Janeiro deixou de se manifestar no feito, tendo transcorrido o prazo legal para a contestação in albis.

No Evento 59, decretada a revelia do Estado do Rio de Janeiro e determinada a vinda dos autos conclusos para sentença.

Manifestou-se a parte autora, Evento 71, tendo juntado ofício da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias e afirmado que esse réu informou que o medicamento requerido foi inserido em planejamento de compra do Município, mas que depois foi negado o fornecimento ao autor, E juntou documento ao Evento 73 para fins de comprovação de que houve negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa.

*É o relatório. **DECIDO.***

Inicialmente, afasto a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que resta demonstrado nos autos que o autor buscou e não teve acesso na esfera administrativa ao medicamento requerido judicialmente.

Passo à análise de mérito.

Narra a parte autora, em síntese, que é paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84) desde seus 03 (três) anos de idade, e necessita, conforme laudo emitido em 21/08/2024, do uso do medicamento elencado no receituário do Evento 23, RECEIT2, para seu tratamento, sob pena de agravamento de seu quadro clínico, oferecendo proteção neural hábil a mitigar os efeitos cognitivos atribuídos a condições de desenvolvimento neurológico.

Afirma que “ necessita do fornecimento de 48 frascos de 30 mL do Canabidiol Golden CDB Plus 200 mg/ml, com o valor de cada frasco de R\$ 1.590,00 (x 48) + frete de R\$ 2.940,00. Igualmente, em anexo, traz-se a documentação médica completa do Autor no qual é possível verificar todas as informações supra mencionadas. No mais, o paciente está autorizado pela ANVISA a realizar a importação do medicamento”.

A medicação prescrita a autor e requerida por meio da presente ação é Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus 200mg/ml - Frasco 30ml.

Conforme informações prestadas pelo NATJus no parecer juntado ao Evento 34, “CONSIDERANDO os diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista constantes nos relatórios médicos acostados ao processo; CONSIDERANDO que a medicação pleiteada carece de estudos robustos para sua utilização como no caso concreto e que não parece ter havido esgotamento das possibilidades terapêuticas segundo inferência do relatório médico. CONSIDERANDO que o diagnóstico supracitado representa patologia crônica, não tendo sido evidenciado nos autos razão para considerar risco iminente de vida ou perda irreversível de órgão ou função CONCLUI-SE que não há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação do medicamento pleiteado”.

Informou o NATJus, ainda, que “No SUS temos a risperidona para o autismo infantil Como opções terapêuticas para transtornos comportamentais, há o haloperidol, periciazina, clorpromazina, levomepromazina, sulpirida, além de outros antipsicóticos atípicos, como olanzapina, clozapina, quetiapina, ziprasidona, aripiprazol, a depender da idade/peso do paciente. Podem também ser utilizados outros antidepressivos, como amitriptilina, imipramina, clomipramina, fluoxetina ou escitalopram. Como psicoestimulantes, há o metilfenidato e lisdexnftamina.”

E esclareceu o NATJus que “Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não”.

Destaco, ainda, as informações prestadas no Evento 54, no Parecer Técnico do NATJUS-FEDERAL Nº 1638/2024:

3. O parecer técnico-científico, elaborado em dezembro de 2023 pelo Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde – Hospital Sírio Libanês (NATS-HSL), que avaliou os **derivados da Cannabis** e seus análogos sintéticos para o tratamento do **transtorno do espectro autista** (TEA), identificou evidência de baixa certeza dos referidos produtos quando comparados ao placebo. Adicionalmente, não foram encontrados estudos que avaliassem os efeitos da *Cannabis* quando comparada a outras tecnologias, como a Risperidona, presente no SUS⁷.

4. Com base no exposto, **na presente data não foi verificada por este Núcleo evidência científica robusta que possibilite inferir acerca da eficácia e segurança** da utilização do pleito **canabidiol 200mg/mL full spectrum Golden CBD Plus** no tratamento de pacientes diagnosticados com **transtornos do neurodesenvolvimento, autismo ou TDAH**.

Ante o teor das alternativas terapêuticas listadas no parecer do NATJus, bem como tendo em vista as informações técnicas de baixa evidência científica de eficácia do tratamento requerido para pacientes com o quadro clínico do autos, consigno que não restam demonstrados os requisitos legais para a concessão ao autor do medicamento requerido, fármaco não padronizado pelo SUS.

Isso porque os fármacos requeridos não são padronizados pelo SUS para tratamento da patologia da autora, e, assim, o deferimento do pleito autoral fica condicionado à verificação do atendimento aos requisitos estabelecidos no REsp nº 1.657.156, Tema 106 STJ, que estabelece que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Por todo o exposto, a improcedência dos pedidos é medida de rigor.

*Pelo exposto, **JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, e RESOLVO O MÉRITO** nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.*

Sem custas e honorários advocatícios, conforme arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Interposto recurso em face da sentença de mérito, vista à parte recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos às Turmas Recursais, nos moldes do art. 1.010, § 3º, do CPC, que dispensa a análise dos requisitos de admissibilidade pelo Juízo de primeiro grau.

Transitado em julgado, e mantidos os termos da presente sentença, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.

P.R.I."

Recorre a parte autora pleiteando a reforma da sentença sob a alegação da imprescindibilidade do tratamento específico, da impossibilidade de o autor arcar financeiramente com os custos da medicação e da comprovação científica da eficácia do tratamento.

É o breve relatório.

VOTO

A sentença não merece reforma.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora postula o fornecimento estatal de produto importado e sem registro na ANVISA.

Quanto ao tema, é essencial partir do entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 1161):

"Tese: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS."

Ainda sobre o assunto, o STF se manifestou no **Tema 500** e fixou a seguinte tese:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas

agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

Compulsando os autos, o parecer do NAT-JUS elenca uma série de opções terapêuticas (34.1) disponíveis no SUS:

"No SUS temos a risperidona para o autismo infantil.

Como opções terapêuticas para transtornos comportamentais, há o haloperidol, periciazina, clorpromazina, levomepromazina, sulpirida, além de outros antipsicóticos atípicos, como olanzapina, clozapina, quetiapina, ziprasidona, aripiprazol, a depender da idade/peso do paciente. Podem também ser utilizados outros antidepressivos, como amitriptilina, imipramina, clomipramina, fluoxetina ou escitalopram. Como psicoestimulantes, há o metilfenidato e lisdexnftamina."

Ademais, o parecer elaborado pelo NAT-JUS, apresenta diversos estudos científicos que apontam que os efeitos a longo prazo ainda não desconhecidos, de forma que sua prescrição não deve ser encorajada em detrimentos de outras opções medicamentosas:

"No momento deste estudo, não foram encontrados ensaios clínicos publicados controlados por placebo sobre o uso de cannabis medicinal para TEA e os estudos observacionais têm limitações. A cannabis medicinal rica em CBD parece ser uma opção eficaz, tolerável e relativamente segura para muitos sintomas associados ao TEA; no entanto, a segurança em longo prazo é desconhecida no momento.

Deste modo, o uso de CBD em quadros de TEA ainda carece de evidências científicas sólidas, de modo que sua prescrição rotineira não deve ser encorajada em detrimento de opções medicamentosas com evidências científicas mais significativas em relação a eficácia e segurança."

Dessa forma, não cabe ao Poder Judiciário conceder medicamentos com base na simples preferência do jurisdicionado ou de seus representantes, sobretudo aqueles com evidências científicas limitadas e efeitos desconhecidos a longo prazo, com elevado ônus financeiro para o Estado e quando não houve esgotamento das alternativas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que não restou demonstrado pela parte autora.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e na forma da fundamentação supra. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em 10% do valor atualizado da causa, observados os parágrafos 2º e 3º do art. 98 do CPC. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.